

Patient Evolution 360
REFERENCIA DE API — /API/V1

DOMINIOS CRUDOS

- GET status
- GET visits
- GET clinical
- GET diagnostics
- GET committee
- GET notes
- GET medications
- GET labs
- GET perception-survey
- GET engagement
- GET surveys
- GET cost
- GET completeness

CAJAS CALCULADAS

- GET cambios-clave
- GET consultas
- GET clinico
- GET costo

COMBINADAS / ACCIONES

- GET dossier
- GET panel
- POST chat
- POST search/chat

Referencia de API — Patient Evolution 360

Forma exacta de la respuesta de cada endpoint, sacada directo del código fuente y **verificada contra las 17 rutas de datos corriendo en local con un paciente real** (BigQuery, 88 citas, ID_USUARIO 2775). {id} es la cédula (IDENTIFICACION) o el ID_USUARIO del paciente — cualquiera de los dos funciona igual en todas las rutas /patients/{id}/...

✓ **Ensayo de verificación (2026-09-18):** se corrieron en vivo las 13 rutas crudas, las 4 cajas calculadas, /dossier y /panel contra datos reales. Se corrigieron 6 discrepancias que el código por sí solo no dejaba ver: tipos numéricos donde se había asumido string (nivel_riesgo, puntaje_total, respuesta_numero, valor_obtenido), el shape real de prog_especialidad_acta en /committee (objetos, no strings — distinto del mismo campo en el borrador de acta), el formato de fecha sin hora en cost.items, y el rango real (no acotado a 100) de adherencia_historica.porcentaje. Las rutas de acción (chat, acta/*, search/chat) se verificaron por código (invocan al modelo, no se ensayaron en vivo para no gastar cuota de Gemini).

Nota general (verificada contra la API real, no solo el código): los campos de fecha que vienen de columnas TIMESTAMP de BigQuery traen offset de zona horaria, ej. "2026-03-14T16:30:00+00:00" — no asumir formato local sin offset. Los helpers internos clean(...) normalizan NaN/NaT de BigQuery a null antes de serializar — nunca vas a ver NaN en el JSON, pero ojo: algunos campos de texto libre capturados desde Excel/formularios (como vitales_recientes.nivel_azucar) pueden traer literalmente el string "null" en vez de JSON null cuando el dato de origen ya venía así — hay que tratarlo como "sin dato" en ambos casos.

13 RUTAS DE DATOS CRUDOS

Un dominio por ruta — cada una toca solo las tablas de ese dominio.

GET /api/v1/patients/{id}/status

Historial completo de transiciones de estado del programa GIRIS, del más viejo al más nuevo.

```
{
  "current_status": "ACTIVO",
  "history": [
    {
      "fecha": "2025-06-28T09:30:00",
      "estado_inicial": "PROSPECTIVO",
      "estado_final": "ACEPTADO",
      "observacion": "..." // o null
    }
  ]
}
```

GET /api/v1/patients/{id}/visits

Historial completo de citas + un resumen por especialidad (conteo de atendidas y última fecha).

```
{
  "visits": [
    {
      "fecha": "2026-01-10T08:00:00",
      "especialidad": "Medicina General",
      "clase_cita": "...",
      "estado": "Atendida" // Programada | Atendida | Usuario Cancela | Medico Cancela | Reprogramado | Comité
    }
  ],
  "specialty_summary": [
    { "especialidad": "Medicina General", "visitas_atendidas": 4, "ultima_fecha": "2026-01-10T08:00:00" }
  ]
}
```

GET /api/v1/patients/{id}/clinical

Historial clínico por consulta — diagnóstico, conducta, vitales, medicaciones, epicrisis (recortada) y análisis de evolución.

```
{
  "n_consultas": 12,
  "n_con_epicrisis": 2,
  "n_con_analisis": 1,
  "consultas": [
    {
      "fecha": "2026-02-03T10:00:00",
      "diagnostico_codigo": "E119",
      "diagnostico_descripcion": "Diabetes mellitus no especificada",
      "diagnostico_capitulo": "Enfermedades endocrinas",
      "conducta": "...",
      "peso": "78", "altura": "165",
      "medicaciones": "...",
      "prescripcion_medica": "...",
      "epicrisis": "(fragmento de texto, o null)",
      "analisis": "(texto libre, o null)"
    }
  ]
}
```

GET /api/v1/patients/{id}/diagnostics

Lista deduplicada de TODO diagnóstico CIE-10 que el paciente haya tenido alguna vez (no por consulta — un diagnóstico repetido en 5 consultas aparece una sola vez).

```
{
  "n_diagnostics": 6,
  "diagnostics": [
    { "codigo_cie": "E660", "descripcion_cie": "OBESIDAD DEBIDA A EXCESO DE CALORIAS", "capitulo": "Enfermedad" }
  ]
}
```

GET /api/v1/patients/{id}/committee

Historial de junta médica / actas médicas, con el ENTRADA_CLOB ya parseado en sus sub-campos estructurados.

```
{
  "n_actas": 5,
  "ultimo_nivel_riesgo": 1,
  "cambio_reciente_nivel_riesgo": { "de": 1, "a": 2, "fecha": "2026-03-01T00:00:00+00:00" } // o null,
  "actas": [
    {
      "fecha": "2026-03-05T16:05:55+00:00",
      "nivel_riesgo": 1 // entero, No string,
      "analisis_plan": "...",
      "observaciones": "...",
      "metricas_relevantes": { "presion_arterial": "127/83", "nivel_azucar": "", "hba1c": "" } // dict<string,
      "diagnosticos": ["G933 SINDROME DE FATIGA POSTVIRAL"],
      "prog_especialidad_acta": [
        { "id": 37, "dias": "60", "id_profesional": 2768 }
      ] // lista de OBJETOS (id de especialidad, plazo en días, profesional asignado) – no strings,
      "ordenes_servicio": ["..."],
      "medicamentos_prescritos": ["Naltrexona (dosis baja)"]
    }
  ]
}
```

Verificado contra datos reales: nivel_riesgo/ultimo_nivel_riesgo son enteros (no strings como en el borrador de acta), y prog_especialidad_acta aquí es una lista de objetos estructurados — distinto del prog_especialidad_acta del [borrador de acta](#) (abajo), que sí es una lista de strings libres redactados por el modelo.

GET /api/v1/patients/{id}/notes

Notas de coordinador/médico de 3 fuentes unificadas, más nueva primero.

```
{
  "n_notas": 8,
  "notas": [
    {
      "tipo_nota": "CLINICA" // CLINICA | ACTA_MEDICA | OPERATIVA,
      "fecha_nota": "2026-02-20T00:00:00",
      "fecha_modificacion": "2026-02-21T00:00:00",
      "nota": "..."
    }
  ]
}
```

GET /api/v1/patients/{id}/medications

Historial completo de medicamentos/prescripciones, más el diff (agregados/suspendidos) entre las dos fechas de prescripción más recientes.

```
{
  "n_medicamentos": 14,
  "medicamentos": [
    {
      "fecha": "2026-03-01T00:00:00",
      "especialidad": "Medicina Interna",
      "nombre_medicamento": "Metformina 850mg",
      "principio_activo": "Metformina",
      "codigo_atc": "A10BA02",
      "nombre_grupo": "...", "nombre_subgrupo": "...",
      "diagnostico_visita": "..." // o null
    }
  ],
  "cambio_reciente": {
    "fecha_anterior": "2026-01-05T00:00:00", "fecha_actual": "2026-03-01T00:00:00",
    "agregados": ["..."], "suspendidos": ["..."],
    "diagnosticos_registrados_en_esa_visita": ["..."]
  } // o null si hay < 2 fechas de prescripción
}
```

GET /api/v1/patients/{id}/labs

Resultados de laboratorio/imágenes, en dos formas: lista cronológica de exámenes completos, y tendencias por parámetro (para graficar).

```
{
  "n_examenes": 5,
  "examenes": [
    {
      "fecha": "20260215" // string YYYYMMDD, no ISO,
      "tipo_examen": "...", "disciplina": "...", "subcategoria": "...",
      "resultados": [
        { "parametro": "HbA1c", "valor": "6.1", "unidad": "%", "referencia": "...", "estado": "normal" }
      ],
      "notas_medico": "..."
    }
  ],
  "tendencias": {
    "HbA1c": [
      { "fecha": "20260215", "valor": "6.1", "unidad": "%", "referencia": "...", "estado": "normal" }
    ]
  }
}
```

GET /api/v1/patients/{id}/perception-survey

Respuestas de encuestas de percepción — mezcza escalas clínicas validadas (PHQ-9, GAD-7, C-SSRS...) con el perfilamiento de engagement "Perfil Personal Girs".

```
{
  "n_cuestionarios": 3,
```

```
"cuestionarios": [
  {
    "nombre_cuestionario": "PHQ-9",
    "tipo_cuestionario": "...",
    "fecha_inicio": "2026-08-06T12:37:14+00:00", "fecha_fin": "2026-08-06T15:51:31+00:00",
    "puntaje_total": 0.0 // float, NO string, "clasificacion_final": "Completado (Puntuación: 0)",
    "completado": true,
    "respuestas": [
      {
        "pregunta": "3. Canal preferido", "respuesta_texto": "", "respuesta_numero": null,
        "respuesta_fecha": null,
        "valor_obtenido": 0.0 // float, NO string, "opciones_seleccionadas": ["whatsapp", "texto", "teléfono"]
      }
    ]
  }
]
```

Verificado: puntaje_total, respuesta_numero y valor_obtenido son numéricos (float, incluso cuando el valor es un entero como 14 llega como 14.0) — NO strings, muchas respuestas de texto libre traen respuesta_numero: null y valor_obtenido: 0.0 por defecto.

GET /api/v1/patients/{id}/engagement

Historial de contacto (WhatsApp/SMS/llamada) vía GHL — estadísticas agregadas + los mensajes recientes.

```
{
  "n_mensajes_total": 120,
  "por_direccion": { "outbound": 77, "inbound": 43 },
  "por_tipo": { "sin_tipo": 120 } // en la práctica GHL casi nunca reporta el tipo - no asumir que siempre viene
  "ultimo_contacto": "2026-06-24T11:59:32.597000+00:00" // o null,
  "mensajes_recientes": [
    { "fecha": "2026-06-24T11:59:32.597000+00:00", "direction": "outbound", "tipo": null, "estado": "delivered" }
  ]
}
```

GET /api/v1/patients/{id}/surveys

Encuestas de satisfacción (NPS-style), una por cita.

```
{
  "n_encuestas": 4,
  "encuestas": [
    {
      "fecha": "2026-02-01T00:00:00",
      "recomienda_servicio": 9, "satisfaccion_medico": 10, "rating": 9,
      "pudo_resolver": "SI", "dificultad": "Ninguna", "comentarios": "..."
    }
  ]
}
```

GET /api/v1/patients/{id}/cost

Ítems de costo/facturación línea por línea. Sin cálculo de PMPM/per-cápita (deliberado, fuera de alcance v1).

```
{
  "disponible": true,
  "costo_total": 4520000.0,
  "costo_por_tipo_servicio": { "Consulta": 300000.0, "Hospitalización": 4000000.0 },
  "n_items": 9,
  "items": [
    {
      "mes_emision": "2024-08-01", "mes_reporte": "2024-09-01" // fecha SIN hora (YYYY-MM-DD), distinto del de
      "codigo_diagnostico": "M55X", "diagnostico": "Espondilitis Anquilosante", "prestador": "Fundacion Clínica
      "tipo_servicio": "Laboratorio Clínico", "codigo_cups": null, "descripcion_servicio": "Eritrosedimentación
      "cantidad": 1, "costo": 43000.0
    }
  ]
}
```

Si el paciente no tiene registros de costo: {"disponible": false, "motivo": "...", "items": []}. Verificado: codigo_cups viene null con frecuencia (no todo servicio tiene CUPS); mes_emision/mes_reporte son fecha pura sin componente de hora, a diferencia de las demás fechas del API que sí traen hora+offset.

GET /api/v1/patients/{id}/completeness

Qué tan completo está el registro de este paciente (útil para que quien consuma la API sepa cuánto confiar en un "no hay datos").

```
{
  "n_citas": 5, "n_consultas": 5, "n_con_epicrisis": 0,
  "epicrisis_fill_rate": 0.0,
  "n_actas_medicas": 3, "n_transiciones_estado": 8,
  "primera_consulta": "2025-06-13T20:14:46", "ultima_consulta": "2025-08-06T17:20:00"
}
```

4 RUTAS CALCULADAS

Una por caja de la interfaz — combinan varios dominios y agregan alertas/derivaciones (nunca vía LLM, solo Python determinista).

GET /api/v1/patients/{id}/summary/cambios-clave

Nivel de riesgo, vitales, cambio de medicación y narrativa clínica reciente.

```
{
  "nivel_riesgo": { "actual": 1 // entero, NO string, "cambio_reciente": { "de": 1, "a": 2, "fecha": "..." } },
  "vitales_recientes": { "fecha": "2026-08-27T13:46:48+00:00", "presion_arterial": "127/83", "nivel_azucar": "
  "cambio_medificacion": { /* mismo shape que medications.cambio_reciente */ } // o null,
  "analisis_evolucion_reciente": { "fecha": "...", "texto": "..." } // o null,
}
```

```
epicrisis_reciente": { "fecha": "...", "texto": "..."} // o null,
"nota_clinica_reciente": { /* shape de notes.notes[i] */ } // o null
}
```

Nota: estado_actual y alertas también los calcula esta caja, pero al llamarla sola vienen incluidos en el /panel combinado (ver abajo), no repetidos aquí — al pedirta suelta por su ruta propia Sí trae estado_actual y alertas tal cual arriba.

GET /api/v1/patients/{id}/summary/consultas

Adherencia histórica, engagement, asistencia y perfilamiento.

```
{
  "coordinador_asignado": "Maria Pérez" // o null,
  "perfil_riesgo_encuesta": { "nombre": "Perfil Personal Giris", "puntaje_total": 0.0 // float, "clasificacion",
  "notas_clave": ["Canal preferido: WhatsApp"],
  "nota_operativa_reciente": { /* notes.notes[i] */ } // o null,
  "adherencia_historica": { "n_recomendadas": 4, "n_atendidas": 26, "porcentaje": 650 } // o null - OJO: porce
  "especialidades_incumplidas": [
    { "especialidad": "Cardiología", "atendidas": 1, "no_asistidas_por_paciente": 3, "ratio_incumplimiento": 0
  ],
  "ultima_cita_atendida": { "fecha": "...", "especialidad": "..."} // o null,
  "proxima_cita": { "fecha": "...", "especialidad": "..."} // o null,
  "dias_sin_visita_atendida": 12 // o null,
  "dias_sin_contacto": 3 // o null,
  "escalas_clinicas": [ { "nombre": "U. Antes de tu consulta médica", "puntaje_total": 14.0 // float, NO strin
  "perfilamiento": {
    "comprende_beneficio": { /* respuesta del cuestionario, o null */ },
    "ha_desertado_previamente": { /* ... */ },
    "proxima_cita_confirmada": { /* ... */ },
    "cambio_coordinadora_reciente": { /* ... */ }
  }
}
```

GET /api/v1/patients/{id}/summary/clinico

Tendencias de labs, diagnósticos, medicación activa, completitud.

```
{
  "tendencias_labs": {
    "HbA1c": {
      "valor_actual": "6.1", "unidad": "X", "fecha_actual": "20260215",
      "referencia": "...", "estado_actual": "normal",
      "delta": -0.3, "dias_desde_anterior": 45, "n_lecturas": 3,
      "historial": [ /* mismo shape que Labs.tendencias[param][i] */ ]
    }
  },
  "diagnosticos_por_capitulo": { "Enfermedades endocrinas": 4, "Trastornos mentales": 2 },
  "diagnosticos": [ { /* mismo shape que diagnostics.diagnostics[i] */ },
  "medicacion_activa": [ { /* medications.medicamentos[i], solo de la fecha mas reciente */ },
  "medicamentos_acta_referencia": ["Maltrexona (dosis baja)"] // o null,
  "completitud": { /* mismo shape que GET .../completeness */ }
}
```

GET /api/v1/patients/{id}/summary/costo

Costo total, por tipo de servicio, outliers, percentiles vs. cohorte.

```
{
  "disponible": true,
  "total": 4520000.0,
  "por_tipo_servicio": { "Consulta": 300000.0, "Hospitalización": 4000000.0 },
  "por_mes": { "2026-01": 300000.0, "2026-02": 4220000.0 },
  "outliers": [
    { "tipo_servicio": "Urgencias", "promedio_mensual": 1.2, "meses": [ { "mes": "2026-02", "cantidad": 5 } ]
  ],
  "atencion_urgente": [
    { "categoria": "Hospitalización", "cantidad": 2, "costo": 4000000.0, "meses": ["2026-02"] }
  ],
  "percentiles": {
    "n_pacientes_comparados": 112,
    "percentil_costo_total": 92, "percentil_hospitalizacion": 95, "percentil_urgencias": 40,
    "pct_hospitalizacion_del_total": 88, "pct_urgencias_del_total": 3
  } // o null si "disponible" es false
}
```

RUTAS COMBINADAS Y DE ACCIÓN

Fuera de /api/v1 — para reproducir la interfaz actual o interactuar con el agente.

GET /patients/{id}/dossier

Los 13 dominios en una sola llamada. Cada clave tiene exactamente el shape de su ruta /api/v1 equivalente (arriba), más un bloque patient al inicio.

```
{
  "patient": { "id_usuario": 3311, "identificacion": "59517" },
  "status": { /* = GET .../status */ },
  "visits": { /* = GET .../visits */ },
  "clinical": { /* = GET .../clinical */ },
  "committee": { /* = GET .../committee */ },
  "diagnostics": { /* = GET .../diagnostics */ },
  "notes": { /* = GET .../notes */ },
  "medications": { /* = GET .../medications */ },
  "labs": { /* = GET .../labs */ },
  "perception_survey": { /* = GET .../perception-survey */ },
  "engagement": { /* = GET .../engagement */ },
  "surveys": { /* = GET .../surveys */ },
  "cost": { /* = GET .../cost */ },
  "completeness": { /* = GET .../completeness */ }
}
```

GET /patients/{id}/panel

Las 4 cajas calculadas combinadas — el mismo payload que consume la interfaz de chat. Ojo: acá estado_actual y alertas. Si se sacan de cambios-clave/consultas y quedan a nivel raíz (no duplicados dentro de cada caja), y completitud sale de clínico y también sube a la raíz.

```
{
  "paciente": { "id_usuario": 3311, "identificacion": "59517" },
  "estado_actual": "ACTIVO",
  "alertas": [
    { "tipo": "cambio_nivel_riesgo", "severidad": "alta", "mensaje": "..." }
    // tipos posibles: cambio_nivel_riesgo, cambio Medicacion, sin_visita_reciente,
    // sin_contacto_reciente, incumplimiento_especialidad, completeness, riesgo_desercion, satisfaccion_baja
    // severidad: alta | media | baja
  ],
  "completitud": { /* = GET .../completeness */ },
  "cambios_clave": { /* = summary/cambios-clave, sin estado_actual ni alertas */ },
  "consultas": { /* = summary/consultas, sin alertas */ },
  "clínico": { /* = summary/clínico, sin completitud */ },
  "costo": { /* = summary/costo */ }
}
```

POST /patients/{id}/chat

BODY

CAMPO	TIPO	NOTAS
question	string	obligatorio
session_id	string null	continúa una sesión existente si se manda
role	"coordinator" "doctor"	default "coordinator" — solo "doctor" puede generar acta

RESPUESTA

```
{
  "answer": "He generado el borrador del acta médica...",
  "session_id": "6bf28a57-...",
  "acta_draft": { /* shape del draft, ver acta/update abajo */ } // null si el turno no generó/tocó un borrado
}
```

POST /search/chat

Búsqueda global sobre la cohorte, sin paciente puntual.

BODY

CAMPO	TIPO	NOTAS
question	string	obligatorio
session_id	string null	continúa una sesión existente

RESPUESTA

```
{ "answer": "...", "session_id": "..." }
```

POST /patients/{id}/acta/generate

Genera (o regenera) un borrador de acta médica. Siempre corre como rol médico, sin importar quién llama.

BODY

CAMPO	TIPO	NOTAS
session_id	string null	opcional — continúa una sesión con borrador existente

RESPUESTA — MISMO SHAPE QUE /CHAT

```
{
  "answer": "...",
  "session_id": "6bf28a57-...",
  "acta_draft": {
    "nivel_riesgo": "2",
    "metricas_relevantes": { "hba1c": "6X", "presion_arterial": "125/72 mmHg" },
    "diagnosticos": ["Q933 SINDROME DE FATIGA POSTVIRAL", "F411 TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA"],
    "analisis_plan": "Paciente con diagnóstico de Síndrome de Fatiga Postviral...",
    "observaciones": "Paciente muestra disposición pero ha presentado dificultades...",
    "medicamentos_prescritos": ["Maltrexona (dosis baja - bajo estudio médico)"],
    "ordenes_servicio": [],
    "prog_especialidad_acta": []
  }
}
```

POST /patients/{id}/acta/update

Edita el borrador directamente (sin pasar por el modelo) — el body ES el borrador completo, hay que mandar los 8 campos siempre.

BODY — LOS 8 CAMPOS SON OBLIGATORIOS

CAMPO	TIPO
session_id	string
nivel_riesgo	string
metricas_relevantes	dict<string,string>
diagnosticos	string[]
analisis_plan	string
observaciones	string
medicamentos_prescritos	string[]
ordenes_servicio	string[]
prog_especialidad_acta	string[]

RESPUESTA

```
{ "draft": { /* el borrador ya actualizado, mismo shape que acta_draft arriba */ } }
```

404 si la sesión no tiene ningún borrador todavía (hay que generar uno primero con acta/generate).

POST /patients/{id}/acta/approve

Aprueba el borrador de la sesión. **No escribes en Oracle** — el médico copia el texto formateado a mano al sistema clínico real.

BODY

CAMPO	TIPO
session_id	string

RESPUESTA

```
{
  "draft": { /* el acta_draft tal cual, mismo shape de siempre */ },
  "formatted": "ACTA MÉDICA (BORRADOR — generado por IA...)
\nPaciente: ID_USUARIO=3311, cédula=59517/n...
\n"
}
```

formatted es texto plano (no HTML/Markdown), con secciones: Métricas relevantes, Diagnósticos, Análisis y Plan, Observaciones, Medicamentos prescritos, Órdenes de servicio, Programación próxima especialidad. 404 si la sesión no tiene borrador.

COORDINADOR VS. MÉDICO

La interfaz de chat tiene un selector Coordinador/Médico arriba. **Importante para el mapeo de tecnología:** ese selector NO cambia qué endpoint se llama en la mayoría de los casos — cambia qué se renderiza en pantalla de la MISMA respuesta, y para /chat cambia qué herramientas tiene disponibles el agente, no la ruta HTTP. Solo acta/* es verdaderamente exclusivo de un rol a nivel de red: el botón "Crear Acta Médica" ni siquiera existe en la pantalla de Coordinador.

✓ se usa con ese rol — no se usa / no se ve con ese rol

Tabla principal — qué llamar por rol (sacada de lo que el 360 esconde hoy en pantalla)

Esta es la tabla que tecnología debe usar para decidir qué pedirle a la API. Se armó mirando qué tarjetas/chips esconde HOY la interfaz de patient-evolution-360 según el rol (ej. Coordinador nunca ve la tarjeta de Costo ni la de Diagnósticos/Clinico) — si algo está oculto para un rol ahí, el front nuevo no debería ni llamar esa ruta para ese rol.

DOMINIO / CAJA	RUTA COMPLETA (MÉTODO + PATH)	COORDINADOR	MÉDICO	POR QUÉ (QUÉ ESCONDE EL 360 HOY)
Nivel de riesgo + vitales	GET /api/v1/patients/{id}/summary/cambios-clave	✓	✓	Los dos roles ven esto — pero ver la salvedad de abajo sobre los 3 campos narrativos que trae mezclados esta misma caja.
Adherencia / engagement / perfilamiento	GET /api/v1/patients/{id}/summary/consultas	✓	✓	Ambos roles la usan.
Diagnósticos, labs, medicación activa	GET /api/v1/patients/{id}/summary/clinico	—	✓	El 360 esconde la tarjeta "Clínico" (diagnósticos incluidos) por completo si el rol no es Médico.
Costo / facturación	GET /api/v1/patients/{id}/summary/costo	—	✓	El 360 esconde la tarjeta "Costo" por completo si el rol no es Médico.
Historial clínico crudo	GET .../clinical, .../diagnostics, .../medications, .../labs	—	✓	Mismo motivo que summary/clinico — son las rutas crudas detrás de esa tarjeta: solo las usan los chips de chat exclusivos de Médico (tabla de temas más abajo).
Junta médica / actas	GET /api/v1/patients/{id}/committee	—	✓	Chip "Junta médica y nivel de riesgo" es doctor-only en el chat.
Perfilamiento / barreras / engagement crudo	GET .../perception-survey, .../engagement	✓	—	Al revés que las anteriores — estos chips son coordinador-only en el chat (Médico no las tiene sugeridas, aunque técnicamente podría pedirías igual por chat libre).
Estado, visitas, costo crudo, encuestas NPS, completitud	GET .../status, .../visits, .../cost, .../surveys, .../completeness	✓	✓	El 360 los usa igual en los dos roles.
Redacción de acta médica	POST .../acta/generate, .../acta/update, .../acta/approve	—	✓	El botón "Crear Acta Médica" no existe en la pantalla de Coordinador.

Todas las rutas de esta tabla siguen la firma .../patients/{id}/... igual que el resto del documento — click en cualquiera para saltar a su sección con el shape completo de la respuesta.

Salvedad sobre summary/cambios-clave: esta caja trae mezclados los campos estructurados (nivel de riesgo, vitales — si van para Coordinador) con 3 campos narrativos (análisis_evolucion_reciente, epicrisis_reciente, nota_clinica_reciente — hoy el 360 los esconde para Coordinador). No hay forma de pedir uno sin el otro en el endpoint actual — el front tendría que descartar esos 3 campos al vuelo para Coordinador sin renderizarlos, o pedirle al backend un filtro para que ni siquiera viajen.

Detalle — qué ruta HTTP dispara cada botón/pantalla

RUTA	COORDINADOR	MÉDICO	NOTA
POST /patients/{id}/panel	✓	✓	Se llama UNA sola vez al abrir el paciente, igual para los dos roles — el filtro de qué se muestra es 100% del lado del navegador (ver tabla 2).
POST /patients/{id}/chat	✓	✓	Mismo endpoint para ambos — el rol viaja en el body y decide qué herramientas tiene el agente (ver tabla 3), no qué URL se llama.
POST /search/chat	✓	✓	Modo "🔍 Búsqueda global" — es un toogle aparte del rol. no

			lleva rol en el body, disponible igual en las dos pantallas.
POST /patients/{id}/acta/generate	—	✓	El botón "Crear Acta Médica" solo existe en la pantalla de Médico — Coordinador nunca ve ni puede disparar esta ruta desde la interfaz.
POST /patients/{id}/acta/update	—	✓	Edición inline del borrador — mismo botón, mismo candado.
POST /patients/{id}/acta/approve	—	✓	
Las 13 rutas /api/v1f.../{dominio} + /dossier	—	—	Ninguna la llama la interfaz de chat en ningún rol — son solo para que otras apps (como la de tecnología) las consuman directo. Si tu integración las usa, el concepto de "rol" simplemente no le aplica: son de datos crudos, sin filtro.

Detalle — dentro de /panel: mismo JSON, distinto render en pantalla

El backend no filtra nada aquí — Coordinador y Médico reciben exactamente el mismo payload de /panel; JavaScript decide qué bloques pintar según el rol activo.

BLOQUE EN PANTALLA	CAMPO DEL PAYLOAD	COORDINADOR	MÉDICO
Nivel de riesgo (valor + alerta de cambio)	cambios_clave.nivel_riesgo	✓	✓
Vitales recientes	cambios_clave.vitales_recientes	✓	✓
Análisis de evolución / Epicrisis / Nota clínica (texto narrativo)	cambios_clave.analisis_evolucion_reciente / epicrisis_reciente / nota_clinica_reciente	—	✓
Alertas de deserción / comunicación, coordinador asignado, perfil de riesgo, notas clave, nota operativa	consultas.*	✓	✓
Tarjeta "Clínico" (labs, diagnósticos por capítulo, medicación activa)	clinico.tendencias_labs / diagnosticos* / medicacion_activa	—	✓
Tarjeta "Confianza de los datos"	completitud	—	✓
Tarjeta "Costo"	costo.*	—	✓

Detalle — dentro de /chat: temas sugeridos por rol (solo sugerencia, no una restricción dura)

El agente SÍ puede usar cualquiera de las 13 herramientas de lectura sin importar el rol activo — esta tabla filtra únicamente los chips de "preguntas sugeridas" que aparecen en pantalla. La única diferencia real de backend por rol en /chat es que solo las sesiones de Médico tienen disponible la herramienta de redactar acta médica.

TEMA SUGERIDO	DOMINIO QUE CONSULTA	COORDINADOR	MÉDICO
Estado en el programa	status	✓	✓
Junta médica y nivel de riesgo	committee	—	✓
Historial clínico	clinical, diagnostics, medications	—	✓
Laboratorios	labs	—	✓
Visitas y especialidades	visits	✓	✓
Perfilamiento y barreras	perception-survey	✓	—
Contacto y engagement	engagement	✓	—
Costo y utilización	cost	✓	✓
Satisfacción	surveys	✓	✓
Confianza de los datos	completeness	✓	✓

Ojo con "Costo y utilización": el chip aparece para los dos roles en el chat, aunque la tarjeta visual de Costo solo se pinta para Médico — o sea, un Coordinador SÍ puede preguntarle al agente por el costo del paciente en el chat, aunque no vea la tarjeta con el desglose. Para el /chat y las actas (acta/*) el candado real ya existe del lado del backend (el rol decide qué herramientas tiene el agente, y el botón de acta no llama nada si el rol no es médico) — ahí no hace falta ningún cambio.